Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	CRISTOBAL SILVA VIDAL					Sexo	F		M X
Fecha Nacimiento	08/08/2013	Edad actual	10 años	7 meses		País natal:	CHILE		
Domicilio actual:	Av. Seg. Costanera 1624 L.A.				Teléfono	968739268			
Lengua materna	ESPAÑOL	Grado dominio	comprende X habla X lee X escribe X						
Lengua de uso	ESPAÑOL	Grado dominio	comprende X habla X lee X escribe X						
Escolaridad actual:	5to Básico	Establecimiento	LICEO MIXTO BASICA Nº2						

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 12/03/2024	2. Fecha de la entrevista: 27.03.2025
Nombre: ANA VIDAL ZELADA	Nombre: Ana Vidal Zelada
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante: Madre
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 12/03/2024	2. Fecha de la entrevista: 27.03.2025
Nombre: CARLO ALARCON O.	Nombre: Milisem Reyes Torres
Rol/cargo: PSICOPEDAGOGO	Rol/cargo: Educadora Diferencial
3. Fecha de la entrevista: 23/03/2026	3. Fecha de la entrevista:
Nombre: Cinthia Barrera	Nombre:
Rol/cargo: Psicopedagoga	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

INGRESO AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

*Actualización.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí (especificar)

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología: Retraso Lenguaje	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) medico.

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO | Peso: 3,049 | Talla: 80 cms

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

MADRE PORTADORA DE HEMOFILIA

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Si	No	Traumatismos	Si	No	Encefalitis	Si	No
Obesidad	Si	No	Intoxicación	Si	No	Meningitis	Si	No
Fiebre alta	Si	No	Enfermedad respiratoria	Si	No	Otra(s)		
Convulsiones	Si	No	Asma	Si	No			
Hospitalizaciones	Si	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	Si	No		Vacunas	Si / No

Observaciones:

Cuando nació Cristobal fue hospitalizado tres dias por Ictericia

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 8 m	Se sienta sólo/a: 1º a	Camina sin apoyo: 1º 6 meses
Primeras palabras: 2 años	Primeras frases: 2 años 6 m.	Se viste solo/a: 3 años

Controla esfinter vesical Diurno: 2 a 6 m Nocturno: 2 a 6 M	Controla esfinter anal Diurno: 2 a, 6 m Nocturno: 2 a, 6 m.

Observaciones:

Madre comenta que cristobal habló precoz a los dos años.

En su actividad motora general se aprecia:
☒ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	Si	No	Caídas frecuentes	Si	No	Dominancia lateral	Si	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	Si	No	Prensión	Si	No	Pinza	Si	No
Ensarta	Si	No	Dibuja	Si	No	Escribe	Si	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	Si	No	Manipula y Explora objetos	Si	No
Demanda objetos y compañía	Si	No	Comprende prohibiciones	Si	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	Si	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	No

Observaciones:

Sin observaciones

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones: uso de lentes, madre no recuerda diagnostico

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☒ oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones: Retraso en el lenguaje madre informe que no le dieron un diagnostico del retraso del lenguaje del estudiante.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	Sonidos:	Personas extrañas:
☒ natural ☐ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada	☐ natural ☒ desmesurada

Observaciones: Sin observaciones

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al dia	(Si)	No	Trastorno motor	Si	No
Epilepsia	Si	(No)	Problema bronco-respiratorio	Si	(No)
Problemas cardiacos	Si	(No)	Enfermedad Infecto-contagiosa	Si	(No)
Paraplejia	Si	(No)	Trastorno emocional	Si	(No)
Pérdida auditiva	Si	(No)	Trastorno conductual	Si	(No)
Pérdida visual	Si	(No)	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Sin Observaciones

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☑ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 10 horas

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☒ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a) Otro:

Observaciones:

sin Observaciones

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Ana Vidal Z.	Madre	34	4to M	Dueña Casa
2. Catalina Silva	Hermana	7	2° B	Estudiante
3. Camilo Silva	Hermana	3	-	-
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Portadora de la hemofilia

Observaciones:

Sin Observaciones

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4a	Asistió a jardín infantil	(Sí)	No
Nº de colegios en que ha estudiado	3	Modalidad de enseñanza Regular ☒ Especial ☐ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios:
Cambio de domicilio

Ha repetido curso/s	Sí	(No)	Curso(s)	Motivo:							
Situación actual											
Nivel/curso actual	5° - A		**Dificultad de aprendizaje**	(Sí)	No	**Dificultad para participar**	(Sí)	No	**Conducta disruptiva**	Sí	(No)
Asiste regularmente	(Sí)	No	Asiste con agrado	(Sí)	No	Apoyo familiar en tareas	(Sí)	No	Amigos (as)	(Sí)	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☒ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☒ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☒ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☒ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☒ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY